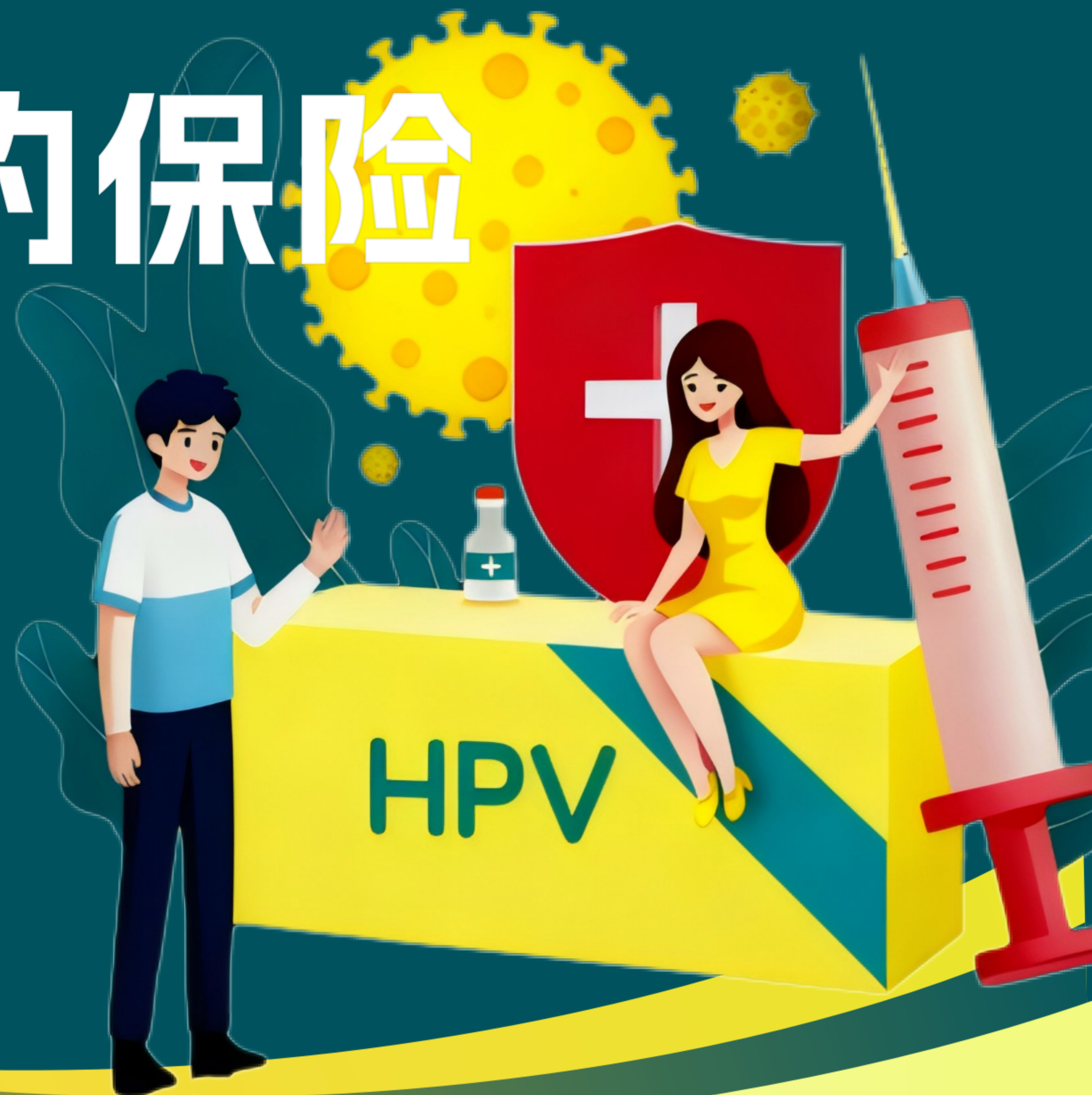


一份给青春的保险 你配置了吗？

大学生HPV公益宣传市场分析

📅 2025.10

🏢 广告创意与策划 第九组 李家宁、曾榛、李佳懿、方奕涵



目录

CONTENTS

01

背景篇

社会环境调查

02

调研篇

定量与定性分析

03

对比篇

同类/相似宣传活
动横向比较

01

背景篇

社会环境调查

调查逻辑



HPV疾病基础与大学生群体风险——感染率与年龄、性别特征

· 男性群体



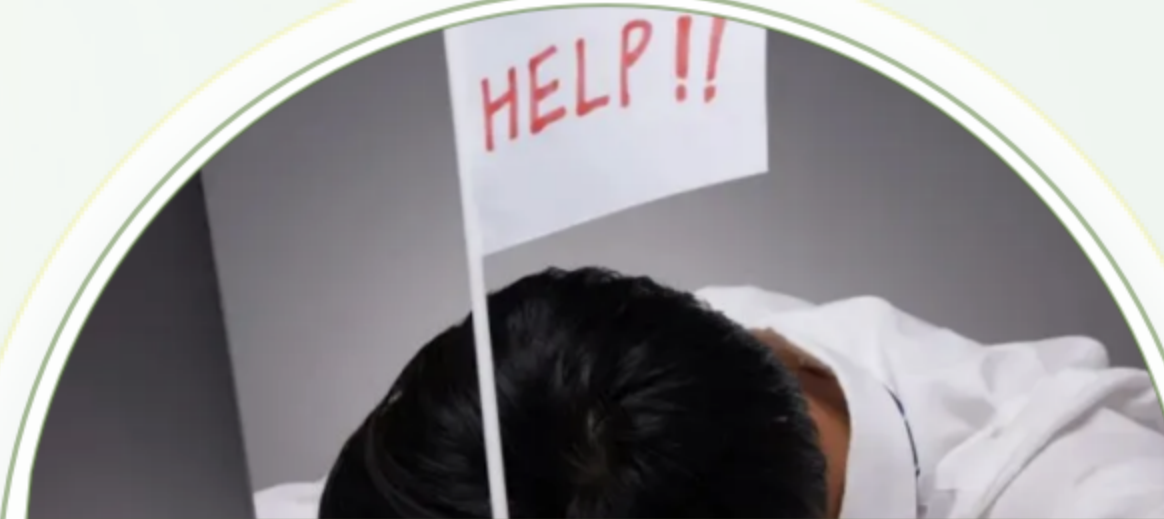
18-24岁

15-19岁男性感染率28%，
25-29岁升至35%，
18-24岁为感染高峰



31%

全球男性生殖器
HPV感染率



39.6%

我国男性总体感染率

来源：2025年美国CDC《国家健康与营养调查》数据、2024年《男性生殖器人类乳头瘤病毒流行率的全球和地区估计》系统回顾

HPV疾病基础与大学生群体风险——感染率与年龄、性别特征

· 女性群体



17-24岁

我国女性HPV感染
首个高峰，与大学
生年龄高度重合



8.3%

北京高校女大学生
高危型HPV感染率



40%

HPV52/58型（高危
型）占比

来源：PubMed 2023年发表的多中心横断面研究（覆盖北京、上海等五地）

HPV疾病基础与大学生群体风险——疾病负担与传播风险



健康危害

《中华预防医学杂志》2025年专家：

HPV持续感染导致女性宫颈癌（99.7%关联）、男性肛门癌（88%关联）等疾病，我国男性HPV相关癌症发病率逐年上升，2020年HPV相关生殖器疣经济负担达41.1亿元。

传播特性

央广网2025年报道：

男性感染后自然清除率比女性低1.5倍，是病毒“隐匿蓄水池”，向伴侣传播概率达60%；大学生社交活跃，为HPV传播提供潜在条件。

大学生认知与接种行为现状



HPV知晓率

78.3%



HPV疫苗知晓率

56.2%



不知道男性也会感染

42.3%

认知水平和误区



认为认知不足是疫苗推广的最大障碍

88.9%



HPV疫苗知晓率

55.8%



不知道男性也会感染

72%

接种率偏低

南昌女大学生接种率

8.7%

杭州未接种大学生

78.29%

接种意愿与阻碍

浙江女大学生未接种主因

担心价格过高
信息不足

62.1%

58.3%

数据来源：《厦门市大学生HPV疫苗认知及接种意愿调查》
《中国疾病预防控制中心周报》
中山大学《大学生HPV认知瓶颈研究》
《中国女大学生HPV疫苗接种现状分析》
《浙江女大学生HPV疫苗接种意向现状及影响因素》
美国CDC数据

HPV预防手段普及现状

疫苗供应与适配性

《中华预防医学杂志》2025年专家倡议明确，国内已批准男性接种四价/九价疫苗，其中九价覆盖HPV52/58型（中国女性高感染型别），可预防92%相关疾病，但九价疫苗供应紧张问题突出。

接种渠道与政策支持

《嘉兴大学“校园HPV接种惠民项目”执行报告》显示，该校联合社区卫生服务中心提供校园接种，已为2000余名学生完成接种，并推行“三针免一针”政策。

科普效果与缺口

《中国学校卫生》2023年系统评价显示，针对性健康教育可使女大学生HPV认知率提升37.2%；但教育部高校健康促进工作白皮书显示，仅19.3%高校开展男性HPV专项科普。



社会传播环境与政策导向



WHO2023年HPV全球防控战略更新显示，已将男性纳入接种战略，标志防控从“单性别”转向“全民防护”。

国际共识



环球网2025年报道显示，长三角50余所高校发起“苗护青春”行动，通过开学季科普与接种服务推动“男女共防”。

国内行动



《杭州市大学生HPV疫苗认知调研》显示，78.6%大学生愿意通过校园活动获取HPV知识。

认知契机

核心结论

当前我国大学生群体对HPV认识普遍不足 校园科普任重道远 形式亟待创新

认知误区

大学生（18-24岁）正处HPV感染高峰，男女均面临显著健康风险，且《中华预防医学杂志》数据显示男性认知缺口更大（72%存在性别专属误区）。

校园责任

校园是科普与接种服务关键场景，嘉兴大学惠民项目、长三角高校联动等案例具备可复制性。

主要障碍

接种意愿与实际接种率严重脱节，价格、信息不足、性别认知误区是主要障碍。

02

调研篇

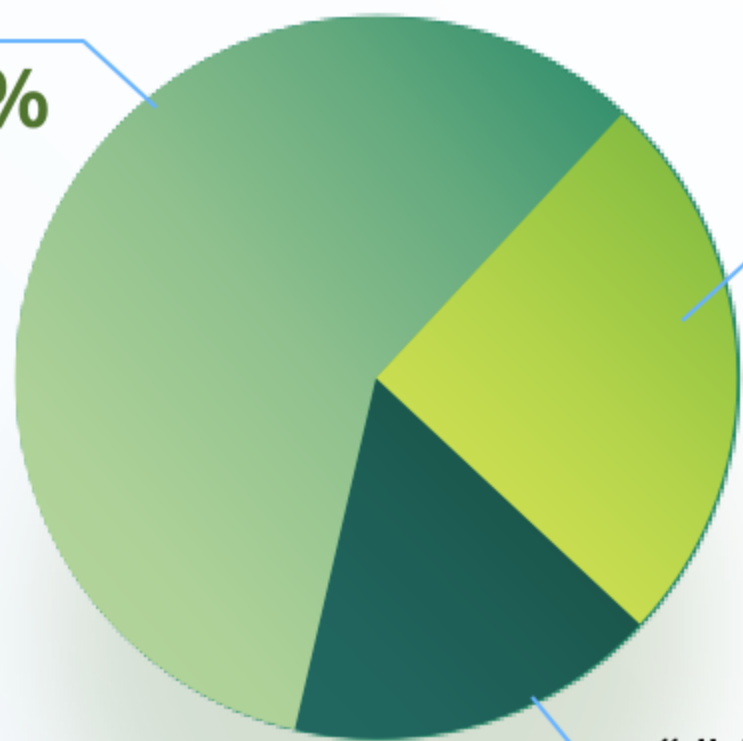
调查、访谈与观察

问卷调查「大学生HPV认知水平调查」结果

*问题：你之前是否了解过HPV（人乳头瘤病毒）？

“比较了解”

58.33%



“听说过但具体不清楚”

25%

“非常了解”

16.67%

基本认知普及率高
但深度了解缺乏，认知误区明显

01男性相关认知逐步改善但仍有差距

98.7%

受访者认为

HPV与所有性活跃期的年轻人都有关系

但仍有 8.33% 受访者认为

HPV仅与女性有关

02预防方式认知全面，但存在“一劳永逸”误区

所有受访者都认可接种疫苗、使用安全套和增强免疫力为有效预防方式，且91.67%认可定期宫颈筛查。

但社媒洞察发现，部分学生误以为——接

种疫苗后即可完全预防——从而忽视

持续筛查的重要性。

03后果认知较清晰，但轻视病毒危害

*问题：你认为持续感染HPV可能导致以下哪些后果？

“可能增加

伴侣感染风险”

91.67%

“可能引起男性肛门癌等疾病”

83.33%

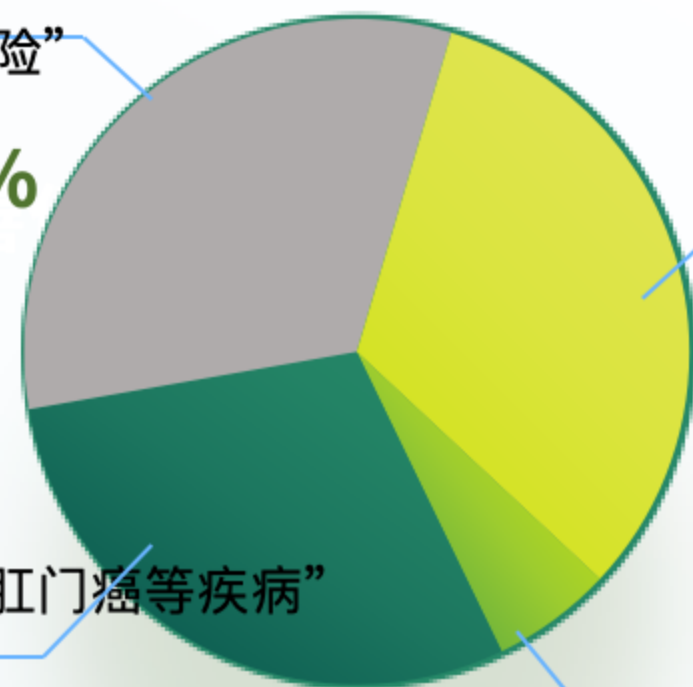
“可能导致女性宫颈癌”

91.67%

“只是一种常见的、

无需在意的病毒”

16.67%

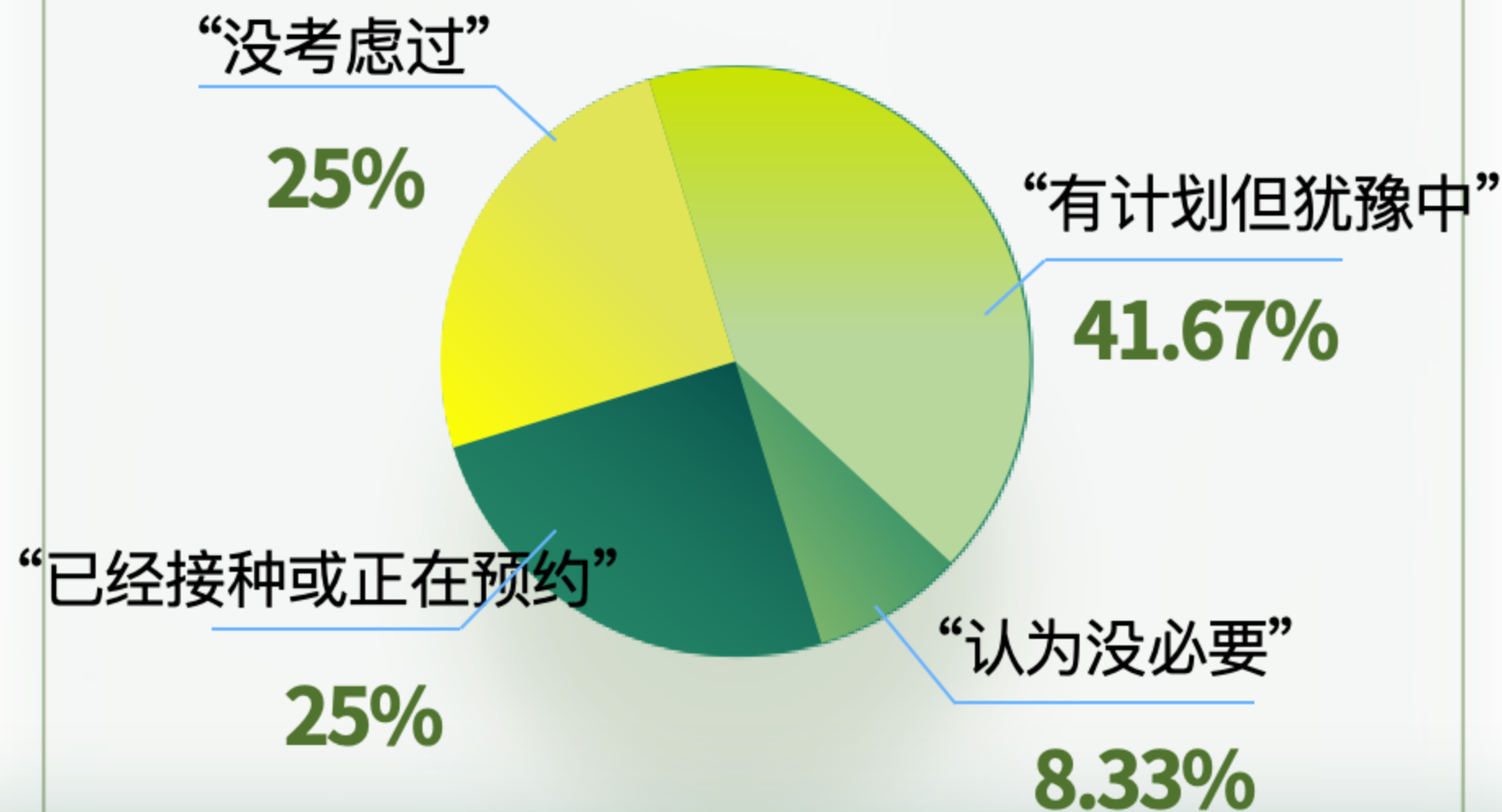


问卷样本量：329

大学生对HPV已建立起广泛的初步认知，
但普遍停留在表面，未能转化为深入、准确的知识体系。

接种意愿与行为障碍「大学生HPV认知水平调查」结果

接种意愿高但行动滞后



01 风险认知低

未接种或犹豫的学生中，**77.78%**
因“预约困难，流程繁琐”

02 流程繁琐

未接种或犹豫的学生中，**88.89%**
“认为自身感染风险低，没必要”

03 疫苗焦虑

55.56%“担心疫苗安全性或副作用”
44.44%“对疫苗缺乏信任或了解”

04 价格昂贵

现注射九价（15-26岁女性）共**2682**元；
在国产九价投入前，三针共**3960**元

问卷样本量：329

“**慎重选择!**会破坏免疫系统平衡，我打了各种副作用，我和亲姐打了都严重脱发和引起荨麻疹，荨麻疹不知道会不会跟一辈子，但愿随时间消去 多年没长痘痘脸上还长了留痕迹的痘痘，青春期那会长痘痘从不留痘印的。脸和身上还长了扁平疣。”

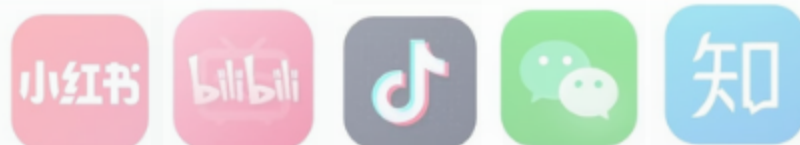
——bilibili网友@账号已注销矣S

大学生在HPV疫苗接种上存在显著的“知信行”差距；

其核心因素并非单一因素，而是一个由内在认知（低估风险）、外部流程（预约繁琐）和情绪焦虑（担心副作用）共同构成的阻力。

信息接受度与传播偏好 媒介调查

➤ 社媒是核心信息阵地



83.3%的受访者表示信息获取来源主要是小红书、bilibili和抖音等新兴社媒；

75%来源于知乎、微博；仅48%来源于学校课程或讲座。

➤ 内容形式上 整体偏好“真人实拍/纪录片式故事”

但现有科普存在突出问题。 “感觉距离自己很遥远，无法共鸣” 67.5%

75% “形式老旧，没有创意”
“术语太多，看不懂” 41.67%

➤ 信源信任情况 权威信源可信度高

66.67%

医学专家或医生

16.67%

博主/UP主

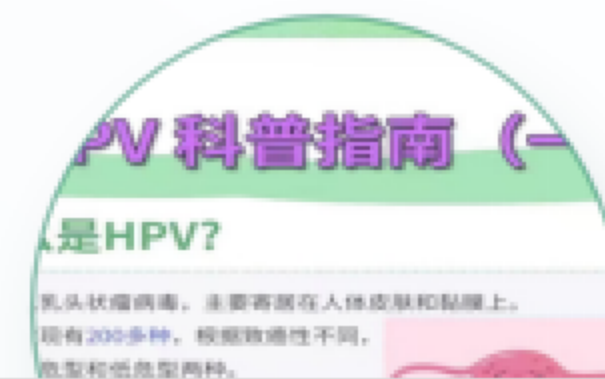
8.33%

患者/同龄朋友

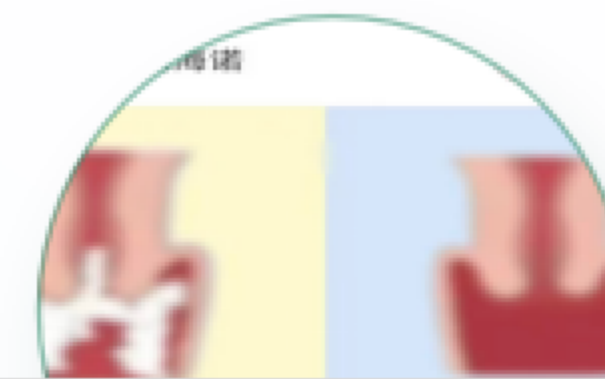
什么样的内容能使其分享？



01 幽默易懂



02 信息密度高



03 视觉冲击力强

什么样的内容能使其行动？

01

清晰展示数据
与后果

02

强调对身边人的
责

有效的传播策略应是以社交平台为主阵地，将专业医学知识通过“专家内核、网红表达”的方式进行转化，从而引发共鸣，驱动行为。



深度访谈 校医

校医从业年限：8年

咨询频率：每年约15-20次HPV相关咨询，3-5例确诊病例（多为低危型）

学生认知水平：中等

存在以下常见误区：
认为只有女性会感染HPV
认为感染HPV=患癌
认为接种疫苗后无需筛查

感染风险因素

自我保护意识不足；
安全套使用不规范
对HPV预防知识了解不足
共用个人物品（如毛巾、剃须刀）
可能传播低危型HPV

预防机制：

每年1-2次，形式包括专家讲座、
海报、公众号推文

疫苗接种支持：

通过班级群、校医院通知接种点
信息合作社区卫生服务中心、甲
医院提供接种服务



深度访谈 辅导员

辅导员从业工龄：2年

负责浙江大学传媒与国际文化学院新闻学/传播学大二、大三、大四年级学生

认知普及与结构性盲区并存

大学生对HPV病毒及其疫苗有基础认知，但仅限于“普遍了解”在男性风险、多重传播路径、疫苗功能等关键科学细节上存在明显误区和知识盲区。

信息渠道非官方化与信任错位

学生主要通过同伴、家庭、网络科普(知名博主)获取HPV信息而非校内官方渠道。

这导致了对校内健康讲座的参与度低，且学生最信任的信息源是知名博主。

有效科普需专业化和娱乐化结合

成功的校园科普活动必须克服“科研和科普的差异性”，活动形式应是“有趣且有反馈的线上线下展览”，并要求内容具备论文出处¹的专业严谨性。



深度访谈 女大学生

有恋爱经历与性生活

以与两性关系较为密切的女大学生为代表案例 深入浅出进行访谈

HPV认知存在恐惧与知识脱节

将HPV与“疫苗”“性病”“害怕”等词汇直接关联，对病毒的警惕性高，同时也伴随恐惧情绪。

认知多源于碎片化信息，存在“知道名字但了解不深”的知识与情绪脱节现象。

男性角色认知:被动且局限

在“男性与HPV”的关系上，受访者的认知局限于消极防御。认为男性在HPV预防中仅能扮演“洁身自好”的角色。

HPV男性风险教育的缺失，以及男性在预防中主动医疗行为（如接种疫苗）意识的不足。

亲密关系中的健康沟通存在障碍

其在亲密关系中并未讨论过HPV“永已话题。主要的沟通困境在于误会”，而非“难以启齿”或“不知道如何科学谈论。

暗示了在亲密关系中，健康话题可能仍被污名化。

深度访谈 男大学生

基本无恋爱经历与性生活

以与两性关系不太密切的男大学生为代表案例 探究男女共防落实程度

风险感知严重不对等

将HPV高度**女性化和宫颈癌化**，
将自身定位为“支持者/协助者”
(支持女友接种、保持忠诚)，
而非“直接风险个体”。

导致缺乏接种疫苗的**主动性**
普遍存在“**与我无关**”的心态

行为障碍源于观念而非行动

接种HPV疫苗的最大障碍并非价格或预约流程，而是“**觉得没有必要**”的观念障碍。

同时对接种环境带有强烈的性别标签顾虑（担心接种地点是妇科或女性专属场所），反映出**男性友好接种环境**的缺乏。

认知获取被动且沟通处于空白

男大学生对HPV的认知主要来自新闻热搜和女性同伴，属于被动接收**以女性为中心的科普信息**。

由于没有性行为或话题敏感性，他们倾向于**主动回避**生殖健康话题，相关知识和实践几乎空白。



调研总结

调研方法|调研结论|后续策划方向

调研方法

- 1.目标人群定量分析：**
设计并发放问卷，回收了118份有效样本。
- 2.社媒心理洞察分析：**
对小红书等社交平台进行了内容分析，深入挖掘了受众的情感情绪和引发共鸣的内容特征。
- 3.关键人物定性访谈：**
完成了对身边同学、校医与辅导员的深度访谈，获得了对学生认知现状、信息渠道及校园干预措施效果的直接洞察。

核心发现整合

认知层面 “名知实不知”

广泛知晓与深度误解并存，对男性风险、疫苗防护局限和病毒危害的结构性认知盲区是阻碍预防的第一道关卡。

行为层面 “高意愿低行动”

“知信行”鸿沟显著，顾虑包括对hpv风险无感、认为接种流程繁琐、疫苗安全焦虑等，共促接种率低的困境。

传播层面 “官方失声，渠道错位”

学生活跃于社媒，信任专家信源，青睐网红的内容，但现有官方科普因形式陈旧、渠道单一而无法触达与共鸣，导致传播失效。

后续策略制定方向与角度

深化认知
“男性同样需要防护”
“疫苗+筛查才是完整防护”
“解读真实风险数据”

促进转化
提升风险感知
简化行动路径
化解疫苗焦虑

优化传播
社媒为主（渠道）
故事化、可视化、互动性强（内容）
寓教于乐、线上线下结合（活动）

03

对比篇

同类/相似宣传活动
横向比较

维度一：活动主体

长三角高校“苗护青春·健康校园”行动

长三角**高校合作联盟**、**地方疾控中心**、**社区卫生服务中心**（多主体联合）

厦门大学“国际HPV知晓日”系列宣传活动

厦门大学**公共卫生学院**、厦门市**妇幼保健院**、**共青团**厦门大学委员会（高校+医疗+校园组织）

华中科技大学“HPV疫苗接种绿色通道”

华中科技大学**校医院**、武汉**同仁医院**（高校医疗+外部医院）

南昌向远轨道技术学校“守护花蕾”专题讲座

南昌向远轨道**技术学校**、厦门市万泰沧海**生物技术有限公司**、南昌市**疾控中心**（学校+企业+官方医疗）

默沙东×阿里健康“向宫颈癌说不”线上项目

默沙东（中国）、**阿里健康**（企业+互联网平台）

共性特点：主体联动成趋势。绝大多数活动采用“高校+医疗/企业”联动的方式，单一主体自主展开的活动（如南昌向远轨道技术学校）占比低

维度二&三：目标人群覆盖——男女共防落实

对比维度

长三角高校
“苗护青春健康校园”行动

厦门大学
“国际
HPV知晓
日”活动

华中科技大学
“HPV疫苗
接种绿色通道”

南昌向远轨道
技术学校向
“守护花蕾”
专题讲座

默沙东x阿里
健康“向宫颈
癌说不”线上
项目

性别覆盖差异：
仅长三角行动明确“男女共防”，其余4个活动都侧重女性，暴露“男性HPV科普缺失”的行业痛点，与策略单“男生误认为HPV与己无关”的认知误区高度契合。

活动痛点：
· 针对“男性认知不足”，借鉴长三角“男性感染风险科普”，避免南昌、阿里健康等活动的性别单一问题；
· 针对“行动滞后”，参考华中科技大学“常态化接种”，降低学生时间成本。

目标人群覆盖

核心:18-22岁
覆盖范围:50余所高校(温州医科大学、嘉兴大学等)

核心:全体师生
覆盖范围:厦大思明、翔安双校区

核心:华科大
延伸:教职工覆盖

核心:该校全部女性师生
覆盖范围：单校初中部和中职部

核心:20-45岁适龄女性
覆盖范围：全国240个城市

男女共防落实

明确强调“男性需为伴侣健康负责”

未落实

部分落实:接种通道向男性开放，但科普内容侧重女性

未落实

未落实

维度四：核心宣传形式

长三角高校“苗护青春·健康校园”行动

线上：无

线下：“开学第一课”科普课堂（讲男性感染风险）、校园接种专场（“三针免一针”惠民政策）疾控专家驻场答疑

厦门大学“国际HPV知晓日”系列宣传活动

线上：无

线下：权威讲座（教授讲疫苗研发、医生讲宫颈癌预防）、趣味互动、疫苗预约咨询

华中科技大学“HPV疫苗接种绿色通道”

线上：学校官微预约

线下：校医院常态化接种、科普展板

南昌向远轨道技术学校“守护花蕾”专题讲座

线上：线上直播

线下：专家专题讲座、海报/黑板报宣传、致家长一封信

默沙东×阿里健康“向宫颈癌说不”线上项目

线上：淘宝搜索“向宫颈癌说不”进入科普平台

线下：无（纯线上）

形式借鉴：参考长三角“开学第一课+惠民接种”模式，结合策略单“线上线下联动”要求，可设计“校园科普周（含男性专场+校医院临时接种点）”。

维度五：转化效果与优劣分析


转化效果


亮点与不足

长三角高校
“苗护青春健康校园”行动

认知层面：嘉兴大学学生反馈“知晓男性也需防HPV”
行动层面：2000余名学生完成接种，区域联动提升接种率

亮点：区域联动（50余校）、实现“科普-接种-惠民”闭环、明确男女共防

厦门大学
“国际HPV知晓日”活动

认知层面：双校区覆盖，知识竞答强化记忆

亮点：多校联动（高校+医院）、趣味互动降低科普枯燥感
不足：忽视男性群体，未形成接种闭环

华中科技大学
“HPV疫苗接种绿色通道”

认知层面：新生入学即接触科普
行动层面：单校每周固定接种时段，2024级研究生“10分钟完成接种”

亮点：常态化接种、校医院便捷落地
不足：科普形式单一（仅展板+讲座）

南昌向远轨道
技术学校向
“守护花蕾”
专题讲座

认知层面：1200余名女性师生了解宫颈癌预防

亮点：覆盖低龄女性（初中部）、家校联动（致家长信）
不足：性别覆盖单一、无接种转化

默沙东x阿里健康
“向宫颈癌说不”线上项目



亮点：线上辐射广、查询便捷
不足：无线下落地、忽视男性，精准触达弱

转化效果差异：有“科普-接种”闭环的活动（长三角、华中科技大学）接种率更高，无闭环的活动（南昌、阿里健康）仅停留在认知层面，符合策略单“需激发行动意识”的核心需求。

避坑提示：避免厦门大学“无接种闭环”、阿里健康“无线下落地”的不足，确保策划包含“认知-咨询-接种”全流程设计。

让我们给青春上一份保险
成就更好的明天

汇报完毕 谢谢大家！

第九小组

10月13日

李家宁、曾榛、李佳懿、方奕涵

小组 分工

• 框架制定与资料搜集 •

李家宁、曾榛、李佳懿、方奕涵

• 社会背景与同类活动对比 •

李家宁

• 人群调研与访谈 •

曾榛、李佳懿、方奕涵

• PPT美化 •

李佳懿、方奕涵、曾榛

• 展示 •

李家宁